Educación diabetológica básica

Insulina, ejercicio, prevención y complicaciones.

40 preguntas · Una única respuesta por pregunta. Aprobado: 28 aciertos o más (al menos el 70 %).

Marca una opción. Cada acierto suma 1 punto; las respuestas incorrectas y sin responder no suman ni restan. El porcentaje se calcula sobre el total de preguntas.

Los ejemplos de insulina son educativos: no sustituyen la pauta individual. En este checklist, 1 ración = 10 g de hidratos de carbono (HC). La plantilla de respuestas está al final, para uso del profesional.

1. ¿Cómo debes conservar tu pluma de insulina una vez empezada?

☐ A. Congelarla para conservarla mejor.
☐ B. Todas las insulinas abiertas deben estar siempre entre 4 y 15 °C.
☐ C. Dejarla al sol si el día no es muy caluroso.
☐ D. Seguir su prospecto y protegerla del calor, la luz y la congelación.

2. ¿Cuánto tiempo puedes usar una insulina después de abrirla?

☐ A. Siempre 14 días.
☐ B. El tiempo indicado en el prospecto de esa insulina y presentación.
☐ C. Siempre 21 días.
☐ D. Siempre 28 días, aunque el prospecto diga otra cosa.

3. ¿Qué debe hacer si la insulina ha sido congelada?

☐ A. Utilizarla
☐ B. Calentarse a temperatura adecuada
☐ C. Almacenarla a temperatura ambiente
☐ D. Desecharla

4. ¿Por qué debes usar una aguja nueva en cada inyección?

☐ A. Para aumentar la cantidad de insulina sin cambiar la dosis.
☐ B. Porque la aguja nueva hace innecesario rotar los puntos.
☐ C. Porque reutilizarla puede aumentar el dolor, dañar la aguja y favorecer obstrucciones o lesiones en la piel.
☐ D. Porque permite compartir la pluma.

5. ¿En qué tejido se debe inyectar la insulina con una pluma?

☐ A. En el músculo.
☐ B. En una vena.
☐ C. En el tejido graso subcutáneo, debajo de la piel.
☐ D. En cualquier tejido, sin diferencia.

6. ¿Cómo se debe proceder al elegir un área para inyectar insulina?

☐ A. Seleccionar un área y rotar sistemáticamente
☐ B. Escoger sin pensar
☐ C. Inyectar siempre en el mismo lugar
☐ D. Elegir cualquier parte del cuerpo

7. ¿Cuál es un factor de riesgo asociado a la reutilización de agujas?

☐ A. Aumento de la insulina
☐ B. Disminución de la efectividad
☐ C. Lipohipertrofia
☐ D. Cirugía innecesaria

8. ¿Qué debes comprobar para administrar correctamente la dosis con una pluma?

☐ A. Solo que haya insulina en la pluma.
☐ B. Que hayas hecho ejercicio antes.
☐ C. Solo la temperatura de la habitación.
☐ D. La insulina, su concentración, la dosis, la aguja nueva y la comprobación de flujo indicada por el fabricante.

9. ¿Cuál es uno de los beneficios de la actividad física y el ejercicio en personas con diabetes?

☐ A. Mejora el control de la diabetes al disminuir el nivel de glucosa en sangre.
☐ B. Provoca un aumento de peso significativo.
☐ C. Reduce la sensibilidad a la insulina.
☐ D. Ayuda a aumentar los niveles de glucosa en sangre.

10. Como referencia general, ¿cuánto ejercicio aeróbico de intensidad moderada se recomienda por semana a la mayoría de adultos con diabetes?

☐ A. 30 minutos en total.
☐ B. Solo 15 minutos.
☐ C. Exactamente 300 minutos para todo el mundo.
☐ D. Al menos 150 minutos, repartidos durante la semana y adaptados a la persona.

11. ¿Qué señal indica que un ejercicio está siendo de intensidad alta para ti?

☐ A. Respiras mucho más rápido y solo puedes decir unas pocas palabras seguidas.
☐ B. Respiras igual que estando en reposo.
☐ C. Puedes cantar cómodamente.
☐ D. No notas ningún esfuerzo.

12. ¿Qué tipo de ejercicio es caminar a paso ligero de forma mantenida?

☐ A. Un ejercicio aeróbico.
☐ B. Un ejercicio exclusivamente de equilibrio.
☐ C. Un ejercicio exclusivamente de fuerza.
☐ D. Un ejercicio de meditación.

13. Si tienes retinopatía proliferativa o no proliferativa grave, ¿qué debes hacer antes de realizar ejercicio intenso?

☐ A. Suponer que cualquier ejercicio es seguro.
☐ B. Evitar caminar para siempre.
☐ C. Consultar las restricciones con tu equipo y evitar los esfuerzos contraindicados para tu caso.
☐ D. Hacer únicamente ejercicio al aire libre.

14. ¿Cuáles son las características del ejercicio aeróbico recomendado?

☐ A. Actividades que usen grandes grupos musculares.
☐ B. Actividades cortas y no rítmicas.
☐ C. Actividades que no requieran esfuerzo.
☐ D. Actividades estáticas.

15. ¿Qué se considera un beneficio del ejercicio físico en la diabetes?

☐ A. Aumento de complicaciones cardiovasculares.
☐ B. Reducción de energía y motivación.
☐ C. Mejora de la autoestima y salud mental.
☐ D. Incremento de la resistencia a la insulina.

16. ¿Con qué frecuencia se recomienda el ejercicio de fuerza a la mayoría de adultos con diabetes?

☐ A. Una vez al mes.
☐ B. Dos o tres sesiones por semana, en días no consecutivos y adaptadas a la persona.
☐ C. Todos los días con los mismos músculos, sin recuperación.
☐ D. Solo cuando suba la glucosa.

17. ¿Qué hábito diario se recomienda además del ejercicio programado?

☐ A. Permanecer sentado el mayor tiempo posible.
☐ B. Evitar todas las actividades físicas.
☐ C. Moverse más e interrumpir los periodos prolongados de estar sentado.
☐ D. Hacer solo estiramientos una vez al mes.

18. ¿Qué se debe hacer antes, durante y después del ejercicio en pacientes con diabetes que reciben insulina?

☐ A. Descartar complicaciones vasculares.
☐ B. Programar una cena abundante.
☐ C. Monitorizar la glucemia.
☐ D. Aumentar la dosis de insulina siempre.

19. En una persona que usa insulina, ¿qué problema puede aparecer durante o después del ejercicio?

☐ A. Mejora de la autoestima.
☐ B. Hipoglucemia.
☐ C. Mejora del acondicionamiento físico.
☐ D. Mayor bienestar.

20. Si usas insulina, ¿cómo puedes prevenir bajadas de glucosa relacionadas con el ejercicio?

☐ A. Vigilando la glucosa y ajustando hidratos o insulina según tu pauta, la actividad y la insulina activa.
☐ B. Aumentando siempre la dosis de insulina.
☐ C. Dejando de hacer cualquier ejercicio.
☐ D. Tomando siempre la misma cantidad de azúcar, sin medir la glucosa.

21. ¿Qué tipo de ejercicio puede ayudar a aumentar la masa muscular en personas con diabetes?

☐ A. Ejercicio de resistencia muscular.
☐ B. Ejercicio aeróbico intenso.
☐ C. Ejercicio de estiramiento.
☐ D. Cualquier tipo de actividad ligera.

22. ¿Qué efecto puede tener el ejercicio regular sobre la sensibilidad a la insulina?

☐ A. Disminuye la sensibilidad a la insulina.
☐ B. Solo afecta a la insulina en ayunas.
☐ C. No tiene efecto sobre la insulina.
☐ D. Aumenta la sensibilidad a la insulina.

23. ¿Qué medida se debe tomar si presenta síntomas de alarma durante el ejercicio?

☐ A. Continuar hasta completar el ejercicio.
☐ B. Tomar un descanso y luego reiniciar sin cambios.
☐ C. Aumentar la intensidad del ejercicio.
☐ D. Interrumpir inmediatamente y buscar atención médica si es necesario.

24. Si usas insulina y vas a hacer ejercicio prolongado, ¿qué debes planificar?

☐ A. No descansar en ningún momento.
☐ B. Controles de glucosa, hidratación e hidratos o ajustes de insulina según tu pauta.
☐ C. Hacer siempre ejercicio de máxima intensidad.
☐ D. No beber agua.

25. ¿Qué práctica se menciona como un factor que puede causar lipodistrofias relacionadas con la insulina?

☐ A. Inyectarse en tejido subcutáneo sano.
☐ B. Usar una aguja nueva.
☐ C. Repetir las inyecciones en los mismos puntos sin rotación.
☐ D. Rotar ordenadamente dentro de una misma zona.

26. ¿Cómo se pueden detectar lipodistrofias?

☐ A. Solo mediante análisis de sangre.
☐ B. Solo cuando aparece dolor.
☐ C. Mediante radiografías.
☐ D. Mirando y palpando sistemáticamente las zonas de inyección.

27. ¿Qué situación puede hacer sospechar problemas de absorción por lipohipertrofia?

☐ A. Glucosas que varían sin explicación y bultos o endurecimientos en las zonas de inyección.
☐ B. Dormir mejor.
☐ C. Tener más apetito.
☐ D. Tener dolor de cabeza únicamente.

28. ¿Qué componente presente en legumbres, frutas y cereales integrales ayuda a moderar la absorción de hidratos de carbono?

☐ A. Proteínas
☐ B. Hidratos de carbono simples
☐ C. Fibra
☐ D. Grasas saturadas

29. ¿Qué se debe hacer si los triglicéridos están elevados en una persona con diabetes?

☐ A. Revisar con el equipo la alimentación, el alcohol, el control de la glucosa y el tratamiento según el nivel de triglicéridos.
☐ B. Aumentar las grasas saturadas.
☐ C. Aumentar el azúcar para sustituir todas las grasas.
☐ D. No hacer ningún cambio.

30. ¿Cuáles son los dos tipos de complicaciones asociadas con la diabetes mellitus ?

☐ A. Temporales y permanentes
☐ B. Inmediatas y latentes
☐ C. Leves y severas
☐ D. Agudas y crónicas

31. ¿Cuál es una de las complicaciones agudas de la diabetes ?

☐ A. Hipertensión
☐ B. Hipoglucemia
☐ C. Insuficiencia renal
☐ D. Retinopatía.

32. ¿Qué situación puede alertar de riesgo de cetoacidosis y requiere seguir el plan de enfermedad y consultar?

☐ A. Una glucosa baja aislada.
☐ B. Tabaquismo sin cambios de glucosa.
☐ C. Colesterol alto sin otros síntomas.
☐ D. Glucosa elevada con cetonas, especialmente si hay vómitos o mal estado general.

33. ¿Cuál es una complicación microvascular común en diabetes ?

☐ A. Infarto cerebral
☐ B. Infarto de miocardio
☐ C. Obstrucción de arterias
☐ D. Retinopatía diabética

34. ¿Qué puede provocar la nefropatía diabética?

☐ A. Problemas de visión
☐ B. Insuficiencia renal
☐ C. Amputaciones
☐ D. Infartos

35. ¿Qué afecta la neuropatía diabética?

☐ A. Vasos sanguíneos
☐ B. Nervios
☐ C. Riñones
☐ D. Corazón

36. ¿Cuál es un síntoma común de la hipoglucemia?

☐ A. Pérdida de peso
☐ B. Náuseas
☐ C. Confusión.
☐ D. Dolor abdominal

37. Si usas insulina, ¿qué riesgo puede aumentar el alcohol, sobre todo si bebes sin comer?

☐ A. Curar la diabetes.
☐ B. Sufrir hipoglucemia, incluso varias horas después.
☐ C. Dejar de necesitar controles de glucosa.
☐ D. Que desaparezcan todas las bajadas nocturnas.

38. ¿Qué debes hacer ante una hipoglucemia si estás consciente y puedes tragar con seguridad?

☐ A. Administrarte más insulina.
☐ B. Tomar hidratos de absorción rápida y volver a medir la glucosa siguiendo tu pauta de tratamiento.
☐ C. Hacer ejercicio intenso.
☐ D. Esperar sin tratarla.

39. ¿Qué situaciones pueden desencadenar una cetoacidosis diabética?

☐ A. Beber agua y mantener la insulina pautada.
☐ B. Omitir o recibir insulina insuficiente, o tener una infección que aumente las necesidades de insulina.
☐ C. Rotar correctamente los puntos de inyección.
☐ D. Cambiar la aguja de la pluma.

40. Durante una hipoglucemia, ¿Qué debe hacerse si el paciente no puede tragar?

☐ A. No dar nada por boca, administrar el glucagón prescrito según su presentación y llamar al 112.
☐ B. Darle un vaso de zumo aunque no pueda tragar.
☐ C. Administrarle insulina rápida.
☐ D. Dejarlo solo hasta que se recupere.

Plantilla de respuestas

Para uso del profesional. Cada letra identifica la única opción correcta de la versión online y de este PDF.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	D	C	C	A	C	D	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	C	A	C	B	C	C	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	D	B	C	D	A	C	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	D	B	B	C	B	B	B	A

Puntuación: aciertos ÷ 40 × 100. Aprueba con 28/40 o más. No redondees el porcentaje antes de decidir el aprobado.

Registro en historia clínica

Checklist: Educación diabetológica básica. Resultado: APRUEBA / NO APRUEBA. Puntuación: ___/40 aciertos (___ %). Incorrectas: ___. Sin responder: ___. Fecha: ___. Versión: 2026-10-12.1.

Adaptación de los cuestionarios aportados para ENDONUTRI. El criterio del 70 % es el establecido para su uso en consulta; no convierte estos checklists en una escala clínica validada. El original se conserva por separado.

Fuentes de la revisión

ADA 2026: Educación y actividad física · Objetivos e hipoglucemia · Riesgo cardiovascular

AEMPS: Tresiba · NovoRapid · Glucagón nasal

Técnica de inyección: FITTER Forward 2025

UCSF Diabetes Teaching Center: HC y cálculo de insulina · Insulina activa e hipoglucemia

Otras fuentes: ESC 2023 · Índice glucémico (Sídney) · Preguntas sobre IG · Lentejas · SAEDYN 2021